

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ - FORMATO CORTO)

International Physical Activity Questionnaire (Craig et al., 2003) · Versión Oficial en Español (IPAQ Research Committee, 2003)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario Internacional de Actividad Física - Formato Corto de 7 Días (IPAQ-SF)
Sigla / Acrónimo	IPAQ (o IPAQ-SF por Short Form)
Autoría original	Consortio Internacional IPAQ (Michael L. Booth, Cora L. Craig, Adrian Bauman et al., 2003)
Adaptación en español	Versión oficial autorizada del Comité IPAQ (2003); Román Viñas et al. (2013, Gac Sanit)
Constructo evaluado	Frecuencia, duración e intensidad de la actividad física habitual y tiempo de sedentarismo diario
Población diana	Población adulta (15 a 69 años) en medicina preventiva, cardiología, atención primaria y epidemiología
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado o mediante entrevista clínica)
Estructura y formato	7 ítems cuantitativos: días/semana y minutos/día de actividad vigorosa, moderada, caminata y sedestación
Condiciones de uso	Dominio público para práctica asistencial e investigación académica citando al Grupo IPAQ

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El sedentarismo y la inactividad física representan uno de los principales factores de riesgo modificables de morbilidad y mortalidad por todas las causas a nivel global, asociándose estrechamente al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, osteoporosis, neoplasias de colon y mama, así como al deterioro de la salud mental (depresión y ansiedad).

Para superar la falta de comparabilidad internacional entre los diversos autoinformes locales de ejercicio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) auspiciaron el desarrollo del IPAQ. Su modelo fisiológico cuantifica el gasto energético metabólico mediante el cálculo de los **METs (Metabolic Equivalent of Task)**, integrando cuatro intensidades funcionales: actividad vigorosa (8.0 METs), moderada (4.0 METs), caminata (3.3 METs) y el tiempo diario acumulado sentado como marcador de riesgo cardiovascular independiente.

3. ESTRUCTURA DE ÍTEMS Y COEFICIENTES MET

Ítems	Dominio Evaluado (Últimos 7 Días)	Ponderación	Definición Fisiológica Operativa
1 y 2	Actividad Física Vigorosa	8.0 METs	Esfuerzo físico intenso que causa respiración mucho más fuerte de lo normal (fútbol, correr, levantar cargas pesadas)
3 y 4	Actividad Física Moderada	4.0 METs	Esfuerzo físico moderado con respiración algo más rápida (ciclismo suave, natación recreativa, fregar suelos)
5 y 6	Caminata / Desplazamiento	3.3 METs	Caminar para trasladarse al trabajo o por placer, de forma continua durante al menos 10 minutos
7	Conducta Sedentaria	Horas/día	Tiempo total sentado en el trabajo, coche, transporte o viendo pantallas

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CORRELATOS BIOMÉDICOS

Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 7-8 días con coeficientes de correlación de Spearman $\rho = 0.75 - 0.81$, demostrando excelente consistencia temporal en 12 países (Craig et al., 2003).
Validez de criterio	Correlación positiva moderada con registros objetivos mediante acelerometría triaxial ($\rho = 0.30 - 0.33$, estándar habitual en autoinformes poblacionales).
Validez concurrente	Correlación superior a 0.67 con la versión larga del IPAQ (IPAQ-LF) y con el Cuestionario de Minnesota de Actividad Física en Tiempo Libre.
Correlatos de salud	La categoría de Actividad Alta predice de forma independiente un menor índice HOMA de resistencia a la insulina ($p < 0.001$), menor tensión arterial media y mejor perfil lipídico HDL.
Sensibilidad al cambio	Capaz de cuantificar con precisión el incremento de gasto energético tras programas de prescripción de ejercicio físico en atención primaria.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES (MET-MINUTOS/SEMANA)

Regla de inclusión mínima	Solo se computan aquellas actividades realizadas de forma continua durante al menos 10 minutos seguidos en los últimos 7 días.
Fórmula de caminata	MET-min caminata = $3.3 \times \text{minutos/día} \times \text{días/semana}$.
Fórmula de act. moderada	MET-min moderada = $4.0 \times \text{minutos/día} \times \text{días/semana}$.
Fórmula de act. vigorosa	MET-min vigorosa = $8.0 \times \text{minutos/día} \times \text{días/semana}$.
Puntuación continua total	MET-minutos/semana Totales = Suma de caminata + moderada + vigorosa.
Regla de truncamiento	Siguiendo el protocolo oficial, duraciones superiores a 180 min/día en una categoría se truncan a 180 min para evitar sesgos de sobreestimación.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Nivel de Actividad	Gasto Energético	Criterio Específico	Significación y Riesgo para la Salud
Bajo / Inactivo	< 600 MET-min	No cumple criterios moderados	Sedentarismo patológico; alto riesgo cardiovascular y metabólico.
Moderado	600 - 2999 MET-min	≥ 5 días de act. combinada	Cumple las recomendaciones mínimas de la OMS para adultos sanos.
Alto / Muy Activo	≥ 3000 MET-min	≥ 7 días o vigorosa intensa	Excelente nivel de acondicionamiento psicofísico y protección global.

PUNTOS DE CORTE Y ALERTAS CARDIOVASCULARES:

- **Nivel Bajo (< 600 MET-min/semana):** Justifica la prescripción formal de "receta deportiva" con objetivo inicial de 150 min/semana de caminata ligera.
- **Sedentarismo > 8 horas/día (Ítem 7):** Factor de riesgo cardiometabólico independiente, aun cuando el sujeto cumpla criterios de actividad moderada puntual.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paso 1: Aplicación del IPAQ-SF: Calcular los MET-minutos/semana totales y las horas de sedestación diaria.

Paso 2: Si Clasifica como "Nivel Bajo" (< 600 MET-min):

- Realizar despistaje cardiovascular previo antes de ejercicio vigoroso si tiene > 45 años o factores de riesgo vascular.
- Prescribir pauta de inicio progresivo: 30 minutos de marcha continua a paso ligero (5 km/h), 5 días a la semana (alcanzando 495 MET-min de base más actividades cotidianas).

Paso 3: Si Clasifica como "Moderado" (600 — 2999 MET-min): Reforzar positivamente y animar a incorporar 2 sesiones semanales de fuerza muscular isométrica/isotónica.

Paso 4: Si Ítem 7 (Sedestación) > 8 horas/día: Pautar "pausas activas" obligatorias cada 60 minutos en el entorno laboral (levantarse 2 minutos para activar bomba muscular gemelar).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE PREVENCIÓN CARDIOMETABÓLICA

Identificación: Paciente varón de 51 años, programador informático en régimen de teletrabajo, derivado por su médico de cabecera tras detectar hipertensión estadio 1 (146/92 mmHg) y sobrepeso grado I (IMC 28.6 kg/m²).

Evaluación Inicial IPAQ-SF:

- Actividad Vigorosa: 0 días/semana (0 MET-min).
- Actividad Moderada: 0 días/semana (0 MET-min).
- Caminata: 2 días/semana durante 15 minutos ($3.3 \times 15 \times 2 = 99$ MET-min/semana).
- Gasto Total = **99 MET-minutos/semana (Nivel Bajo / Sedentarismo Severo)**. Sedestación = **11 horas/día**.

Intervención Conductual: Prescripción formal de ejercicio aeróbico pautado (marcha activa 40 min/día, 5 días/semana) y sustitución de escritorio por mesa elevable para alternar trabajo de pie.

Reevaluación a los 4 meses: La caminata ascendió a 660 MET-min y añadió 2 días de ciclismo suave (480 MET-min), alcanzando **1140 MET-minutos/semana (Nivel Moderado)**. La sedestación bajó a 6.5 h/día, con pérdida de 4 kg y normalización tensional espontánea (128/82 mmHg) sin medicación.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Cardiovascular:

- **Sujetos Sedentarios que Inician Ejercicio Vigoroso:** Exigen valoración médica previa; riesgo de síndrome coronario agudo en esfuerzos desacostumbrados.
- **Dolor Torácico o Síncope de Esfuerzo:** Suspender inmediatamente la actividad física y derivar a Cardiología.

Diagnóstico Diferencial:

- **Sesgo de Deseabilidad Social:** En autoinformes los pacientes tienden a sobreestimar la actividad vigorosa en un 30 – 50%; contrastar con podómetros.
- **Inactividad por Discapacidad:** Diferenciar el sedentarismo voluntario de la limitación motora por osteoartritis o claudicación intermitente.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F., & Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(8), 1381-1395. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB>
- Román Viñas, B., Ribas Barba, L., Ngo, J., & Serra Majem, L. (2013). Validación en población española del cuestionario internacional de actividad física. *Gaceta Sanitaria*, 27(3), 254-257. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.05.014>
- Lee, P. H., Macfarlane, D. J., Lam, T. H., & Stewart, S. M. (2011). Validity of the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF): a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8, 115.
- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Tudor-Locke, C., et al. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(8), 1575-1581.